

() COMPANHAMENTO ☒ CONSULTA
NS

HELTON ALVES DE SOUSA

IDADE: 43 PESO: 100 ALTURA: 1.69 PROFISSÃO: Eng. Mecânico
SINTOMAS: sonolência / pernas cansadas / refluxo.
QUEIXAS: cansaço / boca seca / memória ruim.
MEDICAMENTOS: geifage /
ANALGESICO / Colosterol / DM.
MÉDICO: Dr. Gaisel
MARCAPASSO: () S / N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S / N
EXERCÍCIO FÍSICO: não faz
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: N
HORA QUE DORME: 19h HORA QUE ACORDA: 04
COCHILHO () SIM ☒ NÃO DORME ACOMPANHADO ☒ SIM () NÃO () EVENTUAL
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM ☒ NA SEMANA () NÃO F. Semana
FUMO () SIM () NÃO / DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 1x
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: globosa CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
OVERLAP: Sim MALLAMPATI: II IAH: 84.2 SPO2: 74%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Dor lombar.
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA Tem desvio septo / Rinite
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: IMC: 36.7
COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (M) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA
(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS

24/06 - Avaliação

10/07 não conseguimos realizar a
24 leitura do cartão, vamos abrir chamado
na rumed.
Pte relata melhora da sonolência.
Natacha

31/07/24 P=10. cmH₂O
IAH=1.9 efw
fuga=4.8 lpm.
m. de uso: 5:30' fua

11/12/24 P=9.4 cmH₂O
IAH=1.7 efw Bem adaptada a Siquira
m. de uso: 5h37' Natacha
fuga=0.6 l/m

09/06 P=9.4
25 IAH=1.3 efw cobrei 2x 250.
m. de uso: 5h50' fua
fuga=1.3 lpm

17/03/25

P = 9,8 cm H₂O
 IAH = 1,5 e 1 h
 med. uso: 5 h 23'
 fuso: 4,2 l/m

Vai iniciar atividade
 física

Bem adaptado

Natacha

Nome: HELTON ALVES DE SOUSA

Data de Nascimento: 26-12-1980

IMC: 36,14

Sexo: Masculino

Data do exame: 16-12-2023

Peso: 102 kg

Altura: 1,68 m

Médico: DR. GISEL PEREIRA CALDAS

JUNIOR

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 16-12-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 507,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 9,0 e 183,5 minutos. O tempo total de sono foi de 452,5 min, eficiência de 89,2% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,0%; estágio N2: 70,5%; estágio N3: 10,6%; sono REM: 16,9%. O índice de despertares foi de 60,4/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 84,2/hora, sendo 103 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 87 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e a mínima de 74%, permanecendo 9,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 46 - 103 bpm e NREM de 47 - 101 bpm.

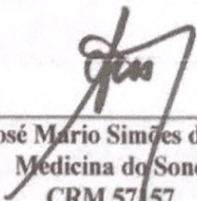
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (20), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 84,2/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=74%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157